Module 2 : Caractéristiques des proches aidants

Cours 3 : Trajectoires multiples de PPA

Objectifs :

- Se sensibiliser à la théorie du parcours de vie.
- Comprendre que les trajectoires des personnes proches aidantes se situent dans leur parcours de vie.
- Nommer des trajectoires possibles de proche aidance.
- Identifier des particularités reliées aux différentes trajectoires de proche aidance.

PPT narré :

- 1 partie (20m35)

Vidéos :

- Renée et son petit fils
- https://www.youtube.com/watch?v=YJMesQQOdp0&t=1s
- Bertrand, sa femme et ses filles
- https://www.youtube.com/watch?v=KtHlGZiK_20
- Anne marie et sa fille
- https://www.youtube.com/watch?v=HHNNiRgMYg0
- https://www.aidantsautray.org/ressources/portraits-daidants/

Lectures :

- Dumont (2015) : La théorie du parcours de vie et la recherche en violence conjugale – p.1 à 5

Théorie du parcours de vie

Portée de la théorie du parcours de vie (de Montigny Gauthier et de Montigny, 2014)

- Analyse de déroulement de la vie d'un individu
- Se base sur les données biologiques et sa réflexibilité
- Prend en compte la dimension temporelle et contextuelle
- Comprend différentes trajectoires et transitions
    - La vie est remplie de plusieurs trajectoires : professionnelle, personnelle, migratoire, amoureuse, proche aidance, etc.
    - Ces trajectoires ne sont pas linéaires. Il y a des périodes de transitions permettant de faire des changements dans la trajectoire.
    - Chacune de ses trajectoires constituent notre parcours de vie.

Principes de la théorie du parcours de vie (Elder, Johnson et Crosnoe, 2004) (cité par Charruault, 2020, p.11)

1) **Le développement tout au long de la vie *(Life Span Development).***
    - Donc de la naissance à la mort.
    - On peut donc apprendre et se développer tout au long de la vie.
2) **La temporalité des événements de la vie (*Timing in lives*).**
    - Les répercussions d'un événement/transition dans son parcours de vie dépend d'où on est rendu dans son parcours et l'ordre dans laquelle ses ed/transitions sont arrivés.
3) **L'insertion des vies dans un temps historique et dans un lieu (*Historical Time and Place*).**
    - Les trajectoires sont façonnées par le contexte historique et social. Ex) le parcours de vie d'une femme en 1945 n'est pas le mm que celui d'une femme en 2025. Le parcours d'une vie en 2025 en Afrique et en Asie diffère l'un de l'autre.
4) **Les vies reliées (*Linked Lives*)**
    - Les parcours de vie sont liés les uns aux autres et interdépendants. Ex) Une mère qui accepte une mutation (changement d'emploi) aura des impacts sur la trajectoire de vie de ses enfants (augmenter le niveau de vie) et sur elle.

5) **L'agentivité (*Human Agency*)**
    - Soit la capacité d'agir d'un individu d'agir sur sa trajectoire de vie via ses décisions (bonnes ou mauvaises)
    - C'est lui qui prend ses décisions mm si parfois elles sont limités

Différentes trajectoires de proches aidants

- L'aide est un continuum, elle se partage parfois entre plusieurs PA.

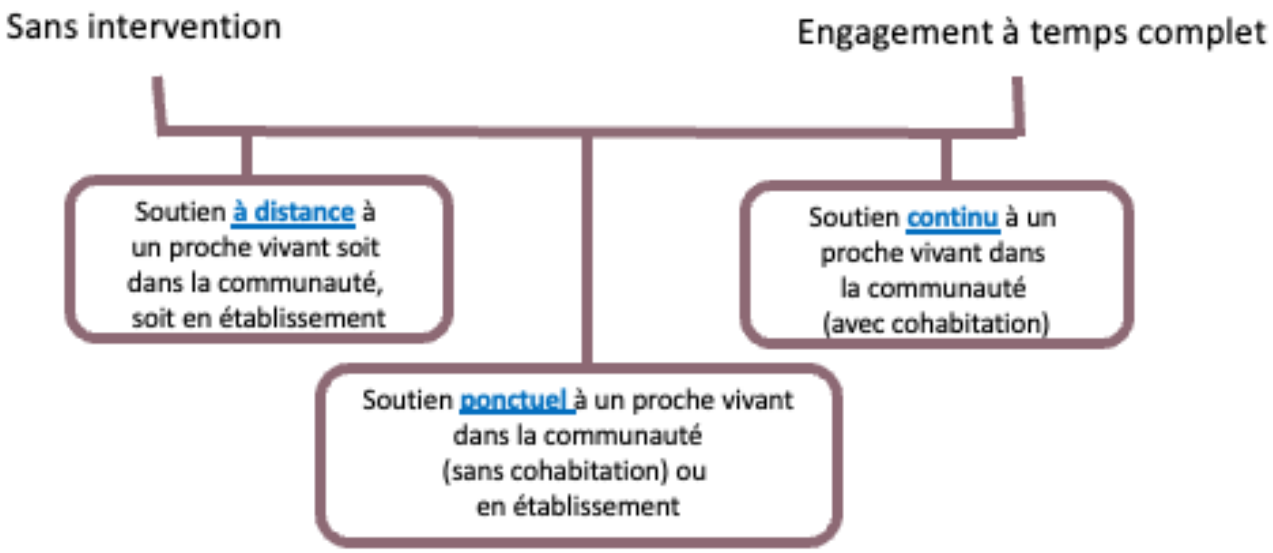
2 types de proches aidants

1. **PA principaux**
    - C'est celui qui est là le plus souvent, qui prend en charge les choses.
    - On l'appel en cas de problème avec l'aidé.
    - Normalement il y a slm 1 PA principal ; le conjoint ou la fille
2. **PA secondaires**
    - Ce sont les autres membres de l'entourage qui aident de façon moins régulière, plus indirect, qui ont un rôle moins important.
    - Ex) les petits enfants, les frères/sœurs, les neveux/nièces
    - Dans la pratique, c'est une notion qui n'est pas si claire.
        - Durant la covid, pour protéger les personnes âgées plus vulnérable à la covid 19 on a fermé l'accès au CHSLD et RPA ('résidence privée pour aîné'). Avec la pénurie de personnel et la restriction des PA pour aider a aggravé la situation et a causé plus de décès.
        - Plusieurs semaines après la fermeture, il y a eu un retour des PA (permis par le gouv.) Le gouv. a donné accès aux PA expérimentés. Les gens n'ont alors pas compris de qui il parlait. Suite de quoi, il a utilisé le terme PA significatif qui a aussi créé de la confusion. Ensuite, il a dit 'PA qui avaient l'habitude d'y aller'. L'impact de cela : créer une hiérarchie chez les PA ☹. Ainsi, des PA secondaires n'avaient pas le droit d'y aller; alors qu'à ce moment ils avaient du temps et le vouloir d'aider. comme ils n'étaient pas principaux

Continuum de soutien

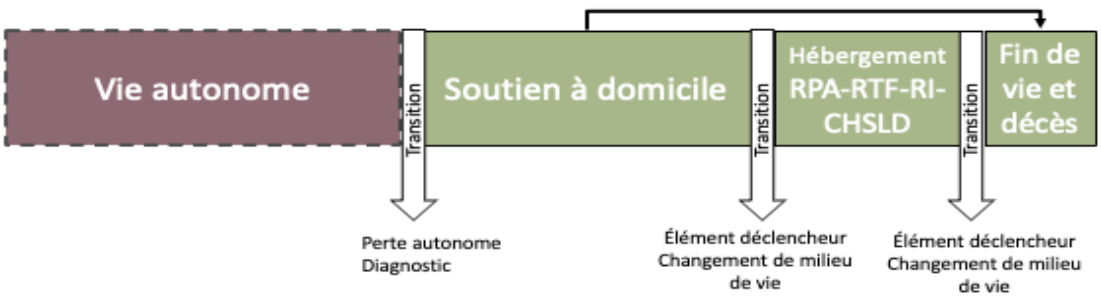
1. **Sans intervention**
    - Soutien à **distance** à un proche vivant soit dans la communauté, soit en établissement.
    - Parfois aider quelqu'un c'est de ne rien faire. Juste être présent, les yeux et oreilles à l'écoute.
2. **Entre les 2**
    - Soutien **ponctuel** à un proche vivant dans la communauté (**sans cohabitation**) ou établissement
    - Ex) appeler l'aider quotidiennement pour lui demander de ses nouvelles (non contact physique)
    - Ex) ponctuel : appeler son proche pour lui rappeler de prendre son médicament, préparer des repas à l'occasion, faire des courses ou son ménage.
3. **Engagement à temps complet**
    - Soutien **continu** à un proche vivant dans la communauté (**avec cohabitation**)
    - Ex) s'occuper d'une personne malade 24h/jour.

- Il n'y a pas de norme pour dire à partir de quand on est PA. C'est souvent un rôle qui arrive doucement et qu'on ne voit pas venir.
    - Ex) Être PA du jour au lendemain : accident de moto, mettre au monde un enfant avec un handicap
    - Ex) Être PA de façon graduelle : PA d'aîné
- Toutes les trajectoires de PA sont uniques. Elle commencent avant le diagnostic de la personne aidée et se poursuit après son décès.



1)Proche aidant d'aîné (la plus commune)

1) **Vie autonome (85% pers. Âgé au QC)**
2) **Transition : perte de l'autonomie + diagnostic** ainsi un PA devient nécessaire
3) **Soutien à domicile (parfois on passe de l'étape 3---7)**
   - L'aîné peut vivre seul ou chez son aidant et ce jusqu'à la fin de sa vie.
4) **Transition : élément déclencheur (état de santé de l'aidé/aidant) + changement de milieu de vie**
5) **Hébergement RPA-RTF-RI-CHSL** fait en sorte qu'il n'Est plus possible de garder à domicile
   - Résidence privée pour aînée (RPA)
   - Ressource de type familial (RTF)
   - Ressource intermédiaire (RI)
   - Centre hospitalier en soin de longue durée (CHSLD)
     - i. Possible d'y rester jusqu'à la mort
     - ii. Les autres milieux il faudra changer la personne âgé éventuellement lorsque que son état se détériorera
6) **Transition : élément déclencheur (santé en chute) + changement de milieu de vie**
   - Les derniers milieu de vie des personnes âgés qui ne décèdent pas à leur domicile sont les maisons de soins palliatifs ou unité de soins palliatifs à l'hôpital.
   - Ici, les personnes aînés ont souvent des troubles cognitifs. Le PA accompli alors son rôle dans un contexte où l'aidé peut être retissant à recevoir de l'aide, parfois agressif, parfois ne reconnaît plus sont PA. Cela a donc un impact sur le PA.
   - Les soins services du PA se modifient dont d'un endroit à l'autre :
     - i. les soins sont plus intenses quand l'aîné est à domicile
     - ii. en hébergement on parle de visite, de la surveillance, de la défense de droit
7) **Fin de vie et décès**

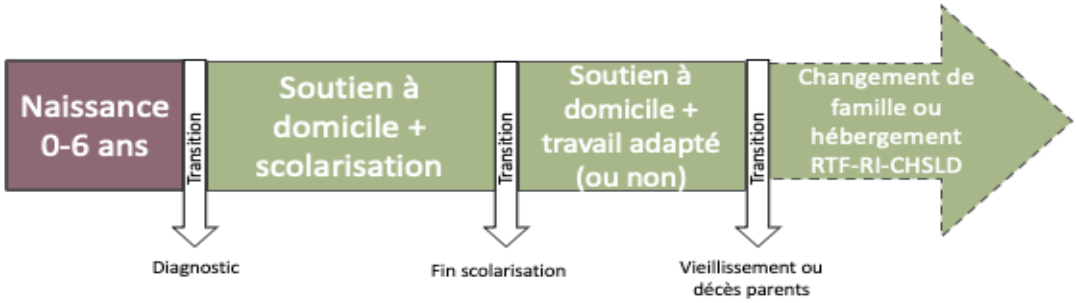


2)Proche aidant d'une personne atteinte de cancer

1) **Vie autonome**
   - Sauf la période entre le diagnostic et la rémission La personne aidée est lucide + accepte l'aide PA
   - Le rôle de PA est temporaire (mois, années) +- intensément
   - Si terminal, alors l'aidé est transféré dans des soins de fin de vie.
   - L'aidé accepte généralement l'aide du PA.
   - PA offre une aide ponctuelle
2) **Transition : diagnostic**
3) **Traitements et soutien à domicile**
4) **Transition : rémission**
5) **Vie autonome**

3)Proche aidant d'un enfant ayant des besoins particuliers

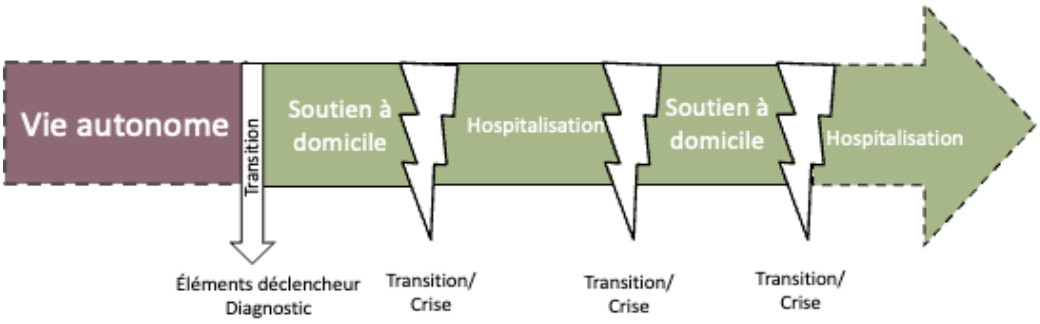
1) **Naissance 0-6 ans**
2) **Transition : diagnostic**
   - Accompagné d'un choc, remise en question pour les parents (carrière, ..)
   - 2 chocs pour les parents : début et fin scolarisation
3) **Soutien à domicile + scolarisation**
4) **Transition : fin de scolarisation**
   - 21 ans fin de la scolarisation
5) **Soutien à domicile + travail adapté (ou non)**
6) **Transition : vieillissement ou décès parents**
7) **Changement de famille (fratrie,..) ou hébergement en RTF-RI-CHSLD**
   - L'enfant peut être +- conscient de ses besoins, donc de ce que son parent fait pour lui (selon son âge, le type de maladie et de déficience)



4)Proche aidance d'une personne avec un trouble de santé mentale (SM)

1) **Vie autonome**
2) **Transition : élément déclencheur + diagnostic**
   - 1e crise suite à des grands changements (peine d'amour, divorce, naissance d'un enfant, décès,…)
   - Le rôle du PA se concrétise avec le dx

3) **Transition / crise** qui provoqueront une hospitalisation
4) **Hospitalisation**
    - Certains auront 1 seule hospitalisation dans leur vie et d'autres plusieurs par années.
    - Les PA sont donc dans un contexte de situations instables.
    - Il arrive que les relations soient tendues entre l'aidé et le PA. L'aidé ne reconnaît pas tjrs ses problèmes, refus d'aide ou de médicament, provoquant des conflits et des réhospitalisassions,…
5) **Transition / crise**
6) **Soutien à domicile**
7) **Transition / crise**
8) **Hospitalisation**



Proche aidant : Mon parcours – étapes (''la trajectoire'')

1) Les premiers signes
2) La prise de conscience
3) Le proche aidant c'est moi !
4) La poursuite de l'engagement
5) Le changement
6) L'aide en fin de vie
7) Le deuil

On a considéré l'impact de la situation des aidées sur les PA, mais les PA aussi peuvent avoir des particularités ayant des impacts dans la relation d'aide

Particularités reliées aux différents profils de proches aidants

- Le PA aussi possède des particularités qui peuvent rendre complexe son rôle de PA.

Proche aidants auxquels on ne pense pas…

- **Les hommes**
    - Les hommes aidants âgés à la retraite ont moins d'amis et se sentent souvent plus isolés que les femmes qui ont tendances à plus socialiser au cours de leur vie.
    - Ils sont environ 40% des PA.
    - Ils reçoivent généralement plus de services de soutien de leur famille et du réseau de la santé. Par contre, ils seront plus facilement jugé s'ils doivent acheter des sous-tiens gorge/culottes à leur conjointe. Ce qui n'est pas le cas d'une femme qui achète des culottes à son conjoint. Donc être homme PA occasionne des difficultés spécifiques.
- **Les jeunes (enfants et adolescents)**
    - Ils sont très peu visible.
    - S'occupent d'un parent atteint de cancer, maladie mentale, parents avec dépendances, s'occupent de la fratrie avec besoins particuliers,…
    - Éprouvent plus de difficultés scolaires que les autres ado. Sont gêné de dire aux profs qu'ils n'ont pas fait les devoirs pcq'un parent atteint de cancer, par ex., a eu besoin d'eux après l'école/pendant la nuit.

- **Les réfugiés, immigrants, minorité ethniques**
    - Ont des difficultés particulières dans leur parcours de PA.
    - Plusieurs ne connaissent pas le réseau de la santé, maitrisent mal ou peu la langue, ne partagent pas les mêmes valeurs familiales, ont de la misère à demander de l'aide pour leur proche et eux, ont peur que cela les pénalise ou peur de certaines représailles
- **Les Premières nations**
    - Possèdent un système de valeur et de santé différent du nôtre.
    - Ils peuvent être jugé dans leur façon de prendre soin des membres de leur famille et pour le type de problème dont sont victime les membres de leur communauté (alcoolisme, toxicomanie, diabète)
- **Les LGBTQ+**
    - Peuvent avoir de la misère à faire reconnaître leur statut auprès de l'aidé (on ne donne pas d'infos médicales lorsqu'on est pas membre de la famille), hors cela peut être difficile de faire reconnaître par ex. qu'on est le conjoint de la personne malade quand on ne correspond pas au couple ou à la famille traditionnelle.
    - Ces personnes/familles différents sont jugées dès le départ et on ne leur donne pas toute la confiance ou la crédibilité comme PA.
- **Les personnes ayant des handicaps physiques ou déficiences intellectuels**
    - Sont aussi aptes à être PA d'un membre de leur famille.
    - Toutefois, ils sont souvent vu comme étant eux mm ayant besoin d'un PA et non l'inverse.
    - On ne les croit pas capable d'aider quelqu'un d'autre. Ainsi, on les ignores dans les plans de soins, on n'écoute pas leur expertise, on ne leur fait pas confiance.

Questions de réflexion !

- **Connaissez-vous d'autres types de trajectoires ou d'autres profils de proches aidants?**
- **Quels sont leurs défis particuliers?**
    - **Démunis financièrement**
        - C'est plus facile d'être à l'aise financièrement et se payer des services de préposés VS couper dans l'épicerie pcq son proche est hospitalisé demandant des soins réguliers (payer le stationnement)
    - **Analphabète**
    - **Monoparentale**
        - C'est pas la mm réalité si tu as un conjoint, de la fratrie qui soutient les activités de vie pendant que l'autre prend soin ou m'aide dans les soins de l'aidé.
    - Il y a donc plusieurs profils de PA et on peut appartenir à plusieurs d'entre eux en mm temps. (ex. LGBTQ, homme et première nation)

Vidéos

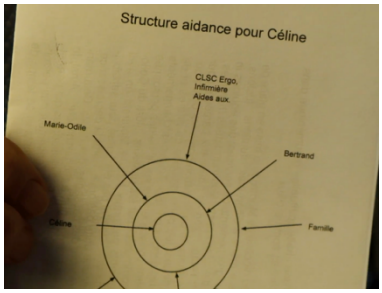
Renée et son petit fils

- **''être proche aidante par amour''**
- Cela fait 1 an qu'elle est PA de son petit-fils.
- Renée est de nature aidante depuis tjrs.
- **Élément déclencheur :**
    - Sa PA a commencé avec le père de ses enfants. Il a eu des enjeux de santé (phlébite).
    - S'en est suivi de son ''copain'' qui a aussi des enjeux de santé (cœur, poumons, reins, jambes). Elle devait faire des pansements tous les jours .

    - S'en est suivi de l'aide d'une dame de son voisinage qui était tombée (enjeu de santé physique). Renée à tous les jours faisaient ses commissions, elle était son référent lorsqu'elle avait besoin, le dimanche bingo.
    - Bref, on constate que Renée essaye d'aider tout le monde/de nature aidante/la rend heureuse.
    - Renée a une fille. Cette dernière a appelé sa mère parce qu'elle était en état dépressif (lien avec un de ses fils). Renée a accepté d'héberger son petit-fils (autiste, tdah, trouble de personnalité, n'aime pas l'autorité). Chose qui demande beaucoup de douceur et patience avec son petit-fils de 19 ans. Renée mentionne être une ''maman gâteau''. Elle dit que par amour, même si ça été difficile, elle recommencerait encore (hébergement). Sa porte est toujours ouverte. Elle aime avoir de ses nouvelles.
        - **Tâches :** faire le ménage, aller le chercher à son emploi, faire les repas, éduqué son petit-fils dans l'apprentissage des tâches (cuisiner, budget, etc.)
- Renée reconnaît son besoin d'aide à elle. Par exemple, sortir de la maison. Ceci dit, elle dit qu'elle doit faire attention pcq'elle ne sait jamais quand est-ce que son petit-fils va arriver à la maison.
- Les enfants de Renée constatent que c'est bcp sur les épaules de leur mère d'avoir un enfant à la maison. Ce à quoi elle répond que lorsqu'elle ne sera plus capable, elle arrêtera.
- Renée dit qu'il est important de parler, communiquer ('le cœur a besoin de se faire aider lui aussi ☺) et de ne rien garder en dedans.
- Aider et donner au suivant, le sens de vie à Renée. Elle redonne ce qu'elle a reçu lorsqu'elle en avait besoin. Elle constate l'importance de parler et de nommer les ressources que trop souvent on ignore l'existence.
- **Lieux 'centre d'aide' nommés par Renée :**
    - Les aidants
    - Un pour tous
    - La Caba, à Bertier
- **Renée a été PA pour :**
    - Le père de ses enfants
    - Son copain
    - Une voisine
    - Son petit-fils

Bertrand, sa femme et ses filles

- **'être PA en famille'**
- Bertrand est PA de sa conjointe Céline depuis 17 ans.
- Histoire du couple :
    - Il rencontre Céline en 1970 dans une réunion du Parti Québécois.
- **Élément déclencheur :**
    - Céline diagnostic en 2008 : Ataxie (maladie dégénérative)
    - En janvier le dx se faisait, 5 mois plus tard Bertrand prenait sa retraite changeant ainsi les plans que c'était fait le couple pour cette période.
- **Le plus grand défi :**
    - Prévenir avec l'ergo du CSLC ce qui s'en vient et gérer les différentes adaptations
        - Quadriporteur
        - Camionnette
        - adaptation de la maison pour le déambulateur
        - chaise roulante
        - le changement des transferts (demande de l'adaptation)
- **Structure aidante pour Céline :**



  - CLSC
  - Personne chèque emploi service
  - La famille
- Selon lui, ça prend de l'amour pour être aidant. Le quotidien amène des Frictions. Bertrand dit qu'il gagne en patience depuis et prend les jours au Fur et à mesure.
- Ils sont encore à la maison et sont heureux de ça. Ca permet de donner l'espace nécessaire à Bertrand quand il en besoin (espace de ressourcement/pouvoir s'isoler).
- **Maladie générative implication sur la vie de Bertrand :**
  - Avant, avec le déambulateur il pouvait partir 2h et sortir de la maison.
  - Maintenant, il ne peut plus quitter. Sa femme a besoin d'une personne a temps plein pour s'occuper d'elle.
- Bertrand est homme qui a besoin de se retrouver/isolement (livre un livre, passer du temps en forêt seul, …). C'est essentiel pour sa santé mental (''ça réaligne les choses'').
- **Ils ont un chien (pero=chien en espagnol) depuis 7 ans.**
  - Être très important pour Bertrand.
  - Il aide Bertrand dans ses maux.
- Bertrand se dit bon aidant, savait déjà faire le lavage et la cuisine lorsque Céline est tombée malade. Cela lui procure de la satisfaction.
- Il a de la misère à mettre des mots sur ce qu'il vit. C'est intense pour lui. Il se pose plusieurs questions sur l'avenir, ça lui donne de l'anxiété. Lui-même est en transition d'aidant à aider. Il dit que ça ne l'habite pas constamment. Il vit bien au ''jour le jour'' (il essaye de ne pas se projeter).
- A ses 70 ans , Bertrand a reçu un dx de Parkinson (maladie dégénérative). Il s'est qu'avec le temps il aura besoin d'aide. Il souhaite que ça sera dans un long délais.
- **Aide pertinente : l'ergothérapeute**
  - Tv se ferme à 22h, suite à quoi c'est la toilette et le lit pour Céline
  - Ensuite, c'est 30 minutes à écouter les nouvelles ou discuter, main dans la main. (moment important pour eux)
- Dans son contexte/son histoire présente, il dit qu'il faut faire des deuils. Par exemple, les deuils de post retraite (acheter un véhicule).
- Il n'a pas de difficulté à demander de l'aide. Même s'il préfère faire ces choses seuls. Mais face à Céline, il demande et accueil l'aide nécessaire, voir même être d'avance sur les coups qui vont survenir dans le futur.
- **Lieu de ressourcement :**
  - AGA Randa (C'est un lieu de rencontre social et plus encore.)
  - CLSC
- **Aide :**
  - Frère et sœur de Céline (ils prennent soins et visitent 1x par mois).
  - Les filles (ils apprécient le retour du balancier (ému))
- **Conseil de Bertrand :**
  - Être attentif
  - Si on veut s'impliquer, c'est d'être présent pour la personne qu'on veut aider.

Anne-Marie et sa fille

- **''être PA en famille''**
- Anne-mère PA de Marie-Ève (sa fille) qui est née avec le syndrome de Townes-Brocks (syndrome très rare, une 100e de personnes dans le monde l'ont)
- **Le syndrome de Townes-Brocks (STB) :**

    - À 1 an, M-E a dû être opéré à cœur ouvert.
    - Elle ne prenait pas de poids, n'avait pas de tonus.
    - Elle n'a pas marché avant 2ans 1|2
    - Elle fait de l'insuffisance rénal, à 15 ans elle a commencé la dialyse, à 18 ans elle a reçu un rein
    - Elle a une légère déficience intellectuelle
    - A 18 ans elle a reçu une greffe
    - A 24 ans elle a eu un tumeur au cerveau cancéreuse, elle a perdu son côté droit.
    - L'espérance de vie avec ce syndrome est de 25 ans.
    - Web def :
        - ''est une maladie génétique rare, à transmission autosomique dominante, définie par une triade classique : imperforation anale, oreilles dysplasiques (parfois avec surdité) et malformations des pouces (pouce triphalangé, bifide)''
- **Élément déclencheur :**
    - Le cancer du cerveau (hémisphère droit retiré)
    - **Avant cela, elle était autonome :**
        - En appartement
        - Elle avait un suivi avec les filandières
        - Elle avait une éducatrice
    - **Post cancer, perte autonomie :**
        - Retour à la maison avec sa mère Anne-Marie
        - Elle doit être gavé (ne peut plus se nourrir)
        - Présentement, elle vit en résidence
            - C'est M-E qui l'a demandé, elle voulait être avec des personnes 'comme elle'.
            - 3 ans d'attente
            - Il y a slm 9 résidents, c'est une ressource communautaire, avec des préposés, infirmière et cuisinière
            - Lui évite d'être en CHSLD
            - Elle est avec un groupe dans ses âges avec des intérêts communs
            - La transition a été difficile pour elle.
                - Impact sur Anne-marie :
                - déchiré de l'intérieur ''est-ce la bonne décision de la mettre en résidence'' (elles ont une relation fusionnelle)
                - laisser les autres s'occuper de sa fille sans s'en mêler et accepter que les autres font différemment (lacher prise pas facile)
- Elle a eu des traitements de radiothérapies qui lui ont permis de marcher avec une marchette. Avec ses traitements au cerveau, s'accompagnait alors la perte de capacité (effets secondaires radio).
- Selon les médecins, elle avait slm 12 % de chances de passé au travers du cancer (hésitant à faire l'opération).
- **Coup de théâtre :**
    - 18 ans plus tard, M-E est encore en vie ('miracle''9 vies'(oncologue)). On peut dire que M-E est extrêmement résiliente! ☺
- **Rôle de vie de M-E selon sa mère :**
    - Elle montre aux autres de ne pas se laisser abattre.
    - Elle donne une leçon de résilience (ex. elle accepte le gavage)
        - Elle a refusé l'aide médicale à mourir
    - Elle est charismatique, cela impact les autres résidents (avec handicap) qui s'occupent d'elle. Elle est aimable.

    - Elle s'est adapté à son nouveau milieu (résidence) et impact positivement la préposé (''son rayon de soleil) par exemple.
- **Rôle présentement d'Anne-Marie :**
    - Rend visite à sa fille 3-4 x par semaine à la résidence
    - Fait partie du conseil d'administration à la résidence et participe aux activités avec les résidents (ex. sorties, balades, activités karaté)
    - Elle sort avec sa fille (cinéma)
        - Maintenant c'est limité à cause du gavage, donc pas de resto.
        - Elles marchent ou vont au cinéma.
        - Ca fait bcp de bien à la mère de passer du temps avec sa fille (sans être dans le rôle de s'occuper mais de profiter)
    - Elle fait du suivi médical (plusieurs spécialistes et donc plusieurs rdv). Elle prend les rdv, l'amène au rdv.
    - Elle s'implique dans la ressource (résidence) ce qui aide au sentiment de sécurité de la mère.
- **Anne-Marie est mère de 2 enfants :**
    - Son fils est devenu aidant pour sa sœur :
        - L'a amené à Niagara, à Ottawa, faire du ski
- **Ancienne travailleuse social (jongler travail – famille) :**
    - Jongler avec les rdv, médecins, tx, travailler
    - Elle a dû prendre des congés/arrêt de travail
        - Plus long : + que 1 an
    - Elle a du faire la dialyse de sa fille à la maison durant la nuit
        - Impact : Anne-Marie ne dort plus et doit aller au travail
    - Après retour à l'hôpital pour l'hémodialyse
    - Elle a été mère monoparental
    - Durant la nuit, comme elle n'arrivait pas à dormir, elle allait du des sites d'échanges pour gens dans la même situations. Elle a rencontré Pierre, conjoint maintenant depuis 25 ans.
- **Impact du nouveau conjoint sur M-E :**
    - Avait l'impression de perdre sa place avec sa mère
    - Aujourd'hui Pierre est extrêmement important pour sa fille et mentionne qu'il a aidé la santé mental de sa mère.
- **Ce qu'a développer A-M :**
    - Patience
    - Travailler sur son caractère avec le personnel médical (pas tjrs se battre pour obtenir des choses)
- **Le plus grand défi :**
    - La culpabilité
        - Ce qui mène à vouloir en faire plus pour compenser (bref une roue qui tourne)
    - On a pas le droit de pas penser à ce qu'on manque, ce qu'on ne peut pas faire
        - Ex. A-M a du canceller son voyage pcq sa fille rentrait à l'hôpital
    - Avoir des soins…c'est difficile. Comme A-M était déjà dans le réseau elle savait par ou passer. Sinon il faut aller vérifier les services qu'on a droit.
        - Ex. Randa
- **A-M, sous l'influence d'une amie, est allé au RANDA**
    - Depuis, ça lui fait du bien de recevoir de l'aide au lieu d'en donner.

Références

Charrault, A. (2020). Le paradigme du parcours de vie. *Caisse nationale d'allocations familiales, 201*, 10-13. https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2020-1-page-10.htm?ref=doi

De Montigny Gauthier, P. et de Montigny, F. (2014). *Théorie du parcours de vie*. Cahier de recherche no 6. Canada, Gatineau : Centre d'études et de recherche en intervention familiale. Chaire de recherche du Canada sur la santé psychosociale des familles. https://cerif.uqo.ca/sites/cerif.uqo.ca/files/cahier6_theorie_du_parcours_de_vie_web.pdf

Dumont, A. (2015). *La théorie du parcours de vie et la recherche en violence conjugale. Fiche synthèse Méthodologique*. Équipe de recherche en violence conjugale. Trajetvi. http://trajetvi.ca/files/publications/fiche-synth-se-parcours-de-vie-finale.pdf

Table de concertation sur les besoins des proches aidants du territoire de la Vieille-Capitale (2015). Proche aidant: mon parcours. https://www.apacn.org/wp-content/uploads/2016/11/Guide_Proche_Aidant_2015.pdf